

پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی

سومین آزمون صلاحیت حرفه‌ای

روان‌شناسان و مشاوران

این مجموعه شامل نسخه اولیه از پاسخ‌های تحلیلی به سؤالات آزمون اخیر بوده است. نسخه‌های تکمیلی شامل توضیحات بیشتر، تحلیل‌های عمیق‌تر به همراه سؤالات دقیق‌تر به زودی منتشر خواهد شد.

لطفاً برای دریافت آخرین به‌روزرسانی‌ها و نسخه‌های نهایی، تنها کانال رسمی من را دنبال فرمایید:

<https://t.me/drtorkamannezam>

با احترام

دکتر محمد ترکمان

نسخه ۱ - تاریخ انتشار: ۵/۵/۱۴۰۴

تذکر مهم ۱

این سوالات و پاسخ‌های تحلیلی صرفاً بر اساس برداشت شخصی و دانش تخصصی نگارنده تهیه شده و به هیچ وجه تأییدکننده سوالات واقعی آزمون یا پاسخ‌نامه رسمی سازمان سنجش یا سازمان نظام روانشناسی نیست.

انتشار این مطالب صرفاً با هدف تحلیل آموزشی و بحث علمی است و هرگونه استفاده دیگر خارج از این چارچوب، مورد نظر نویسندگان نمی‌باشد.

تذکر مهم ۲

تلاش شده است که با مرور منابع، پاسخ سوالات به دقت انتخاب شود اما ممکن است در برخی سوالات محدود، پاسخ انتخاب شده با پاسخ طراح، مغایر باشد. ملاک پاسخ‌ها طبقاً سازمان سنجش و سازمان نظام است. همچنین متن سوال و گزینه‌ها ممکن است با اصل آزمون فرق کند چون به سوالات دسترسی نداشتیم.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۱

اگر مراجع در اتاق درمان قصد حمله فیزیکی به درمانگر را داشته باشد، بهترین واکنش فوری چیست؟

پاسخ:

درخواست کمک فوری به هر شیوه ممکن. در چنین موقعیت بحرانی، اولویت مطلق با حفظ ایمنی جانی و روانی درمانگر، مراجع و دیگران است. هرگونه اقدام درمانی یا تحلیلی، مانند تلاش برای متوقف کردن درمان، به بعد از کنترل کامل بحران موکول می‌شود، زیرا امنیت مشاور بر هر اصل درمانی دیگری ارجحیت دارد.

سؤال ۲

اگر در اتاق درمان، مراجع دروغ بگوید، عکس‌العمل مناسب چگونه است؟

پاسخ:

وارسی دلیل دروغ‌گویی و ارائه تفسیر در زمان مطلوب. مواجهه مستقیم و فوری با دروغ مراجع، به‌ویژه در مراحل اولیه درمان، اقدامی صحیح نیست. دروغ‌گویی در فرآیند درمان یک پدیده

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

قابل انتظار است که می‌تواند دلایل متعددی مانند ترس، شرم یا مقاومت داشته باشد. وظیفه درمانگر، مشاهده‌گری دقیق، واریسی و درک دلایل این رفتار و سپس، در زمان مناسب و پس از شکل‌گیری اتحاد درمانی قوی، ارائه تفسیر یا بازخورد سازنده است، نه مچ‌گیری یا مواجهه تقابلی.

سؤال ۳

مهم‌ترین ابزار سنجش روان‌شناختی کدام است؟

پاسخ:

مصاحبه (به‌ویژه مصاحبه تشخیصی). اگرچه مشاهده و آزمون‌های روان‌شناختی نیز ابزارهای ارزشمندی هستند، اما مصاحبه به عنوان ابزاری پویا که امکان برقراری رابطه، درک زمینه و کاوش عمیق تجربیات ذهنی مراجع را فراهم می‌کند، بنیادی‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار یک متخصص بالینی محسوب می‌شود.

سؤال ۴

هنگام مشاهده توهمات بینایی واضح در مراجع، کدام تشخیص محتمل تر است؟

پاسخ:

دلیریوم (Delirium). اگرچه توهمات در اختلالات روان‌پریشی نیز دیده می‌شوند، اما توهمات شنیداری در اسکیزوفرنی شایع‌تر هستند. وجود توهمات بینایی واضح و شدید، یک نشانه کلیدی برای اختلالات با منشأ عضوی (ارگانیک) است که در میان آن‌ها، دلیریوم به عنوان یک وضعیت اورژانسی پزشکی، محتمل‌ترین تشخیص است و نیازمند توجه فوری می‌باشد.

سؤال ۵

دانشجویی که بین دو انتخاب محل تحصیل در تهران یا شهرستان مردد است، با کدام نوع تعارض روبروست؟

پاسخ:

تعارض گرایش-گرایش (Approach-Approach) Conflict که به آن جاذب-جاذب نیز گفته می‌شود. این

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که فرد باید بین دو گزینه که هر دو مطلوب و جذاب هستند، یکی را انتخاب کند.

سؤال ۶

در کدام دسته از اختلالات، توهم و هذیان به عنوان علائم اصلی وجود دارند؟

پاسخ:

اختلالات روان‌پریشی (Psychotic Disorders) مانند روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی). در سایر دسته‌ها مانند اختلالات روان‌رنجوری (نوروتیک) یا اوتیسم، توهم و هذیان جزء نشانه‌های اصلی و تعریف‌کننده اختلال نیستند.

سؤال ۷

شایع‌ترین توهم کدام است؟

پاسخ:

شایع‌ترین توهم، توهم شنوایی (Auditory Hallucination) است، خصوصاً در اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی.

سؤال ۸

هدف اصلی تکنیک فعال‌سازی رفتاری (Behavioral Activation) در درمان افسردگی چیست؟

پاسخ:

افزایش درگیری مراجع در فعالیتهای لذت‌بخش و معنادار.
این تکنیک که از مؤلفه‌های اصلی درمان شناختی-رفتاری (CBT) برای افسردگی است، بر این اصل استوار است که کاهش خلق منجر به کاهش فعالیت و انزوا می‌شود و این انزوا، افسردگی را تشدید می‌کند. فعال‌سازی رفتاری با ترغیب مراجع به انجام فعالیتهای مثبت، حتی در غیاب انگیزه، به دنبال شکستن این چرخه معیوب و افزایش تماس فرد با تقویت‌کننده‌های مثبت محیطی و در نتیجه، بهبود خلق است. اصل کلیدی در این رویکرد آن است که "عمل بر انگیزه مقدم است".

سؤال ۹

کدام نوع هذیان (Delusion) خطرناک‌تر یا آسیب‌زاتر است؟

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

پاسخ:

هذیان گزند و آسیب (Persecutory Delusion). در حالی که هذیان نفوذ (باور به کنترل شدن توسط نیرویی خارجی) نیز نشان‌دهنده آسیب روانی عمیق است، هذیان گزند و آسیب به دلیل ارتباط مستقیم با احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه، خطرناک‌تر تلقی می‌شود. فردی که معتقد است دیگران قصد آسیب رساندن به او را دارند، ممکن است برای «دفاع از خود» به دیگران یا خود آسیب برساند.

سؤال ۱۰

نشانه‌های اختلال طیف اوتیسم (Autism Spectrum Disorder) معمولاً در چه سنی ظاهر می‌شوند؟

پاسخ:

قبل از سه سالگی. بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)، اگرچه تشخیص قطعی ممکن است پس از سه سالگی (مثلاً بعد از ۳۶ ماهگی) گذاشته شود، اما نشانه‌های اصلی اختلال باید در اوایل دوره رشد، یعنی قبل از سه سالگی، ظاهر شده باشند.

سؤال ۱۱

ارکان اصلی یک مصاحبه بالینی کدامند؟

پاسخ:

بر اساس مدل اُتمر (Othmer)، چهار رکن اصلی برای مصاحبه بالینی تعریف شده است: ۱. رابطه (Rapport)، ۲. تکنیک (Technique)، ۳. تشخیص (Diagnosis)، و ۴. ارزیابی وضعیت روانی (Mental Status Examination). درمان (Treatment) اگرچه هدف نهایی فرآیند است، اما جزء ارکان ساختاری خودِ مصاحبه به شمار نمی‌رود. مصاحبه در بستر یک رابطه درمانی و با استفاده از تکنیک‌های مشخص برای رسیدن به تشخیص و ارزیابی وضعیت روانی انجام می‌شود.

سؤال ۱۲

تظاهرات عینی وضعیت روانی مراجع که توسط متخصص مشاهده می‌شود، چه نام دارد؟

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

پاسخ:

نشانه (Sign). در آسیب‌شناسی روانی، بین دو مفهوم تمایز وجود دارد: «نشانه» که یک یافته بالینی عینی و قابل مشاهده توسط متخصص است (مانند سراسیمگی روانی-حرکتی) و «علامت» (Symptom) که یک تجربه ذهنی و گزارش شده توسط مراجع است (مانند احساس غمگینی). مجموعه‌ای از نشانه‌ها و علائم، یک اختلال (Disorder) را تشکیل می‌دهند.

سؤال ۱۳

در آسیب‌شناسی روانی رد کردن سایر تشخیص‌های احتمالی نشانگر چیست؟

پاسخ:

تشخیص افتراقی (Differential Diagnosis). این یک فرآیند بالینی استاندارد و نظام‌مند است که در آن، درمانگر با بررسی شواهد، سایر اختلالات محتمل که علائم مشترکی با وضعیت مراجع دارند را رد می‌کند تا به دقیق‌ترین تشخیص ممکن برسد. این فرآیند با «همبودی» (Comorbidity) که به معنای وجود همزمان چند اختلال است، تفاوت دارد.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۱۴

عوامل ارثی در ابتلا به اختلالات روانی چه نقشی دارند؟

پاسخ:

عامل	مستعدکننده	یا	زمینه‌ساز
(Predisposing Factor). در مدل دیاتز-استرس، عوامل به چند دسته تقسیم می‌شوند: عوامل زمینه‌ساز (مانند وراثت و ژنتیک) که بستر را برای بروز مشکل فراهم می‌کنند؛ عوامل آشکارساز یا راه‌انداز (Precipitating Factor) که اختلال را فعال می‌کنند (مانند یک رویداد استرس‌زا)؛ و عوامل تداوم‌بخش (Perpetuating Factor) که باعث ادامه یافتن اختلال می‌شوند. عوامل ارثی در دسته اول قرار می‌گیرند.			

سؤال ۱۵

کدام مورد می‌تواند مانع دخالت دادن نیازهای شخصی مشاور در فرآیند مشاوره شود؟

پاسخ:

انگیزه مشاور شدن. در حالی که مهارت‌ها و همدلی به فرآیند درمان کمک می‌کنند، انگیزه‌های ناسالم درمانگر (مانند نیاز

به کسب درآمد، شهرت، قدرت یا ارضای نیازهای شخصی) می‌تواند به عنوان یک مانع جدی عمل کرده و به بی‌طرفی و اثربخشی درمان آسیب بزند. پایبندی به اصل مسئولیت‌پذیری و وفاداری (Fidelity and Responsibility) که ریشه در این انگیزه سالم دارد، مانع از چنین دخالتی می‌شود.

سؤال ۱۶

اگر بین کلام و رفتار غیرکلامی مراجع تعارض وجود داشته باشد (مثلاً بگوید «همسرم برایم مهم نیست» اما لحن صدایش حاکی از ناراحتی باشد)، بهتر است از کدام مهارت استفاده شود؟

پاسخ:

مواجهه (Confrontation). تکنیک مواجهه در روان‌درمانی به معنای بازتاب دادن محترمانه تناقض‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در افکار، احساسات و رفتارهای مراجع است. این کار با هدف افزایش خودآگاهی مراجع انجام می‌شود و باید با ظرافت و تنها زمانی به کار رود که یک اتحاد درمانی قوی شکل گرفته باشد تا مراجع آن را حمله‌ای به خود تلقی نکند و با «مواجهه درمانی» (Exposure Therapy) که برای درمان اضطراب به کار می‌رود، متفاوت است.

سؤال ۱۷

مهم‌ترین تکنیک برای برقراری ارتباط مؤثر چیست؟

پاسخ:

گوش دادن فعال (Active Listening). اگرچه تکنیک‌های دیگری مانند انعکاس، همدلی و خلاصه‌سازی نیز اهمیت دارند، اما گوش دادن فعال به عنوان اساس و قلب فرآیند مشاوره، بنیادی‌ترین مهارت برای ایجاد یک رابطه درمانی قوی و درک عمیق دنیای مراجع است.

سؤال ۱۸

هدف اصلی از گرفتن رضایت آگاهانه (Informed Consent) چیست؟

پاسخ:

مطلع کردن مراجع از فرآیند درمان و حقوقش. هدف اصلی رضایت آگاهانه، احترام به اصل خودمختاری مراجع و تضمین این است که او به طور کامل از ماهیت درمان، هزینه‌ها، حدود رازداری و استثنائات آن، و حقوق قانونی خود مطلع باشد تا بتواند تصمیمی آزادانه و آگاهانه بگیرد. اگرچه این فرآیند

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

می‌تواند به جلوگیری از شکایت‌های آتی نیز کمک کند، اما این هدف فرعی است و هدف اصلی، تحقق حق مراجع برای دانستن است.

سؤال ۱۹

در کدام نوع درمانگری، بازسازی شناختی (Cognitive Restructuring) انجام می‌شود؟

پاسخ:

درمان شناختی-رفتاری (Cognitive-Behavioral Therapy - CBT). این تکنیک، هسته اصلی درمان‌های شناختی (موج دوم) را تشکیل می‌دهد که در آن به مراجع کمک می‌شود تا افکار ناکارآمد و تحریف‌شده خود را شناسایی، ارزیابی و با افکار واقع‌بینانه‌تر جایگزین کند. این رویکرد با درمان‌های موج سوم (مانند ACT) که بر پذیرش افکار به جای به چالش کشیدن آن‌ها تأکید دارند، متفاوت است.

سؤال ۲۰

تکنیک قاب‌گیری مجدد (Reframing) به چه معناست؟

پاسخ:

ایجاد دیدگاه جدید و بینش بیشتر. در این تکنیک، درمانگر با ارائه یک دیدگاه جایگزین، به مراجع کمک می‌کند تا معنای متفاوتی برای تجربیاتش بیابد و در نتیجه، واکنش هیجانی و رفتاری متفاوتی نشان دهد. این کار به معنای ایجاد بینش جدید و افزایش انعطاف‌پذیری شناختی است.

سؤال ۲۱

فعال شدن همزمان چند طرح‌واره و سبک مقابله‌ای چه می‌گویند؟

پاسخ:

ذهنیت (Mode). ذهنیت‌ها، حالت‌های هیجانی و رفتاری لحظه‌به‌لحظه‌ای هستند که وقتی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه فعال می‌شوند، فرد آن‌ها را تجربه می‌کند (مانند ذهنیت کودک آسیب‌پذیر، والد تنبیه‌گر یا محافظ بی‌تفاوت).

سؤال ۲۲

در درمان شناختی رفتاری نسبت دادن کاهش بارندگی به پوشش بانوان، کدام خطای شناختی است؟

پاسخ:

استنباط دلخواهی (Arbitrary Inference). این خطای شناختی به نتیجه‌گیری شتاب‌زده و بدون شواهد کافی، یا حتی با وجود شواهد متناقض، اشاره دارد. در این نوع تفکر، فرد بر اساس باورهای شخصی خود، یک رابطه علی-معلولی غیرواقعی بین دو پدیده برقرار می‌کند.

سؤال ۲۳

مهم‌ترین تکنیک در طرح‌واره‌درمانی کدام است؟

پاسخ:

تکنیک‌های تجربی (Experiential Techniques). این تکنیک‌ها (مانند تصویرسازی ذهنی و کار با صندلی خالی) با هدف قرار دادن هیجانات مرتبط با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، به بازپردازش هیجانی خاطرات کودکی و تغییر الگوهای ریشه‌دار کمک می‌کنند و هسته اصلی و متمایزکننده این رویکرد درمانی را تشکیل می‌دهند.

سؤال ۲۴

کدام مورد در مورد شاغلین حرفه‌های روان‌شناسی صحیح است؟

پاسخ:

عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی و پروانه اشتغال دو مقوله متفاوت هستند. عضویت صرفاً به معنای پذیرفته شدن به عنوان عضوی از سازمان است و یک پیش‌نیاز برای درخواست پروانه محسوب می‌شود. اما پروانه اشتغال، مجوزی است که پس از احراز صلاحیت‌های لازم (از جمله قبولی در آزمون صلاحیت حرفه‌ای) صادر می‌شود و به فرد اجازه کار درمانی مستقل را می‌دهد.

سؤال ۲۵

کدام مورد در مورد ارزش و اعتبار پروانه فعالیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران صحیح تر است؟

پاسخ:

کلیه پروانه‌هایی که توسط سازمان نظام روان‌شناسی به عنوان نهاد قانونی صادر می‌شوند، ارزش و اعتبار یکسانی دارند.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۲۶

اگر یک روان‌شناس بخواهد در استانی با بافت فرهنگی متفاوت فعالیت کند، چه اقدامی ضروری است؟

پاسخ:

آشنایی با مسائل فرهنگی و بوم‌شناختی آن استان و متناسب‌سازی مداخلات. درمانگر موظف است با شناخت فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ای که در آن کار می‌کند، خدمات خود را به شیوه‌ای حساس و متناسب با آن بافت فرهنگی ارائه دهد.

سؤال ۲۷

اگر مراجع از مشاور درخواست کند که جلسات را در مکانی غیر از اتاق درمان (مانند باغ یا ویلا) برگزار کنند، واکنش صحیح چیست؟

پاسخ:

مخالفت قاطع. جلسات مشاوره باید صرفاً در چارچوب حرفه‌ای و در اتاق درمان برگزار شود. پذیرش چنین درخواست‌هایی

مصادق بارز خروج از چارچوب، رابطه دوگانه و نقض مرزهای حرفه‌ای است که اکیداً ممنوع می‌باشد.

سؤال ۲۸

شایستگی حرفه‌ای (Competence) در رشته مشاوره به چه معناست؟

پاسخ:

از منظر قانونی و نظارتی، شایستگی حرفه‌ای با «داشتن پروانه تخصصی» احراز می‌شود. اگرچه جوهر اصلی شایستگی، «توانمندی در تشخیص و درمان مناسب» است، اما پروانه نشان‌دهنده احراز حداقل‌های آموزشی، قبولی در آزمون صلاحیت و قرار گرفتن تحت نظارت و پاسخگویی به یک نهاد قانونی (سازمان نظام روان‌شناسی) است. لذا میتوان گزینه داشتن پروانه و گزینه توانمندی در تشخیص و درمان درست باشد.

سؤال ۲۹

اگر شکایتی علیه یک روان‌شناس در سازمان نظام روان‌شناسی ثبت شود، وظیفه او چیست؟

پاسخ:

در رسیدگی به شکایت با سازمان همکاری می‌کنیم. بر اساس اصول اخلاق حرفه‌ای، روان‌شناس موظف است نهایت همکاری را با نهادهای نظارتی داشته باشد و اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

سؤال ۳۰

اگر درمانگر در فرآیند درمان یک مراجع موفقیتی حاصل نشود، بهترین اقدام چیست؟

پاسخ:

ارجاع دادن مراجع. ادامه درمانی که مؤثر واقع نشده، غیراخلاقی است. ارجاع به یک متخصص دیگر (شاید با رویکردی متفاوت) یک خدمت تخصصی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اولویت دادن به بهزیستی مراجع بر منافع شخصی یا حرفه‌ای درمانگر است. متوقف کردن درمان بدون ارائه گزینه جایگزین، اقدام صحیحی نیست.

سؤال ۳۱

اگر مراجع برای دیگران خطرساز باشد، چه اقدامی باید انجام داد؟

پاسخ:

رازداری نقض می‌شود و باید اطرافیان یا مقامات مسئول را آگاه کرد. این اصل که به عنوان «وظیفه حمایت» (Duty to Protect) شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین استثنائات رازداری است. زمانی که خطر آسیب جدی و قریب‌الوقوع برای دیگران وجود دارد، تعهد درمانگر برای حفظ امنیت جامعه بر تعهد او به رازداری اولویت پیدا می‌کند.

سؤال ۳۲

روان‌شناس باید پرونده‌های درمانی مراجعان را چگونه نگهداری کند؟

پاسخ:

در یک مکان امن و محرمانه در محل کار (کلینیک) و بر اساس اصول رازداری. پرونده‌ها باید به گونه‌ای نگهداری شوند که دسترسی افراد غیرمجاز به آن‌ها ممکن نباشد. بردن پرونده‌ها

به خانه یا نگهداری آن‌ها در مکانی ناامن، غیراصولی است. همچنین، پرونده‌ها پس از اتمام درمان حذف نمی‌شوند، بلکه برای یک دوره زمانی مشخص (معمولاً حداقل پنج سال) بایگانی می‌گردند.

سؤال ۳۳

رفتار اخلاقی در مشاوره مستلزم چیست؟

پاسخ:

رعایت دقیق اصول، چارچوب‌ها و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای. انعطاف‌پذیری در قوانین اخلاقی یا نادیده گرفتن آن‌ها تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست. این کدها برای حفاظت از مراجع و حفظ اعتبار حرفه تدوین شده‌اند و پایبندی به آن‌ها الزامی است.

سؤال ۳۴

مهم‌ترین نتیجه‌ای که از پایبندی به اخلاق حرفه‌ای حاصل می‌شود، چیست؟

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

پاسخ:

حمایت از حقوق مراجع. اگرچه پایبندی به اصول خود یک ارزش است، اما هدف غایی از تدوین و اجرای کدهای اخلاقی، محافظت از حقوق، کرامت و بهزیستی مراجعان، و همچنین مشاوران و خود حرفه است. این امر از طریق پایبندی عملی روان‌شناسان به این اصول محقق می‌شود.

سؤال ۳۵

اینکه مراجع آزاد است فرآیند درمان را شروع، ادامه یا در هر زمان قطع کند، به کدام اصل اخلاقی اشاره دارد؟

پاسخ:

اصل خودمختاری (Autonomy). این اصل بر حق بنیادین مراجع برای گرفتن تصمیمات آگاهانه و آزادانه در مورد درمان خود، بدون اجبار یا فشار از سوی درمانگر، تأکید دارد.

سؤال ۳۶

اینکه تمام فعالیت‌های روان‌شناختی باید در جهت رشد و شکوفایی مراجع باشد، بیانگر کدام اصل اخلاقی است؟

پاسخ:

اصل سودمندی (Beneficence). این اصل به معنای تعهد فعالانه درمانگر برای انجام کارهایی است که به نفع مراجع و بهزیستی او باشد و از وارد کردن هرگونه آسیب به او (اصل عدم ضرررسانی یا Non-maleficence) پرهیز کند.

سؤال ۳۷

به لحاظ اخلاقی مسئولیت جریان مشاوره و مداخلات انجام شده بر عهده کیست؟

پاسخ:

بر عهده روان‌شناس. درمانگر مسئولیت کامل فرآیند درمان، مدیریت زمان، حفظ چارچوب، تکنیک‌های به کار رفته و هدایت جلسات را بر عهده دارد و در قبال آن پاسخگو است.

سؤال ۳۸

بهترین راه برای تنظیم مرزهای درمانی چیست؟

پاسخ:

بیان صریح، شفاف و محترمانه قوانین و چارچوبها در ابتدای درمان. رابطه مشاور و مراجع باید یک رابطه شفاف و مشخص باشد که در آن، نقشها، مسئولیتها و مرزها به وضوح تعریف شدهاند.

سؤال ۳۹

براساس آموزهای اخلاقی حکم شراکت مالی، دوستی و ارتباط آموزشی با مراجع چیست؟

پاسخ:

هر سه مورد ممنوع است. روان‌شناس نباید وارد هیچ‌گونه رابطه دوگانه‌ای (Dual Relationship) با مراجع خود شود. این ممنوعیت شامل روابط مالی، اجتماعی، آموزشی و شخصی می‌شود و حتی تا مدت زمان قابل توجهی (مثلاً دو سال) پس از خاتمه درمان نیز ادامه دارد، زیرا این روابط پتانسیل بالایی برای استثمار، آسیب به بی‌طرفی و مخدوش کردن مرزهای حرفه‌ای دارند.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۴۰

براساس آموزهای اخلاقی ارجاع (Referral) از مصادیق افشا....

پاسخ:

نیست. ارجاع دادن به خودی خود نقض رازداری نیست، زیرا با رضایت آگاهانه مراجع و برای تأمین بهترین منافع او انجام می‌شود و تبادل اطلاعات صرفاً در محدوده لازم برای ادامه درمان و با اطلاع مراجع صورت می‌گیرد.

سؤال ۴۱

چه عاملی می‌تواند به افزایش خلاقیت مراجع در اتاق درمان کمک کند؟

اسخ:

ایجاد یک فضای گرم، پذیرا، صمیمی و منعطف. چنین فضایی به مراجع احساس امنیت و پذیرش می‌دهد و او را برای کاوش و بیان آزادانه خود ترغیب می‌کند که این خود زمینه‌ساز خلاقیت است. محیط خشک و رسمی می‌تواند بازدارنده باشد.

سؤال ۴۲

کدام مورد بیانگر مصداق افشا و عدم رازداری است؟

پاسخ:

درمانگر نمی‌تواند و نباید به مراجع قول رازداری مطلق و صددرصدی بدهد. او موظف است در ابتدای درمان و در فرآیند رضایت آگاهانه، اصل رازداری و همچنین حدود و استثنائات قانونی آن (مانند خطر آسیب جدی به خود یا دیگران، کودک‌آزاری و حکم دادگاه) را به روشنی برای مراجع توضیح دهد. قول رازداری مطلق، خود یک خطای اخلاقی است.

سؤال ۴۳

یکی از اصول کلیدی اخلاق حرفه‌ای چیست؟

پاسخ:

احترام به استقلال و تصمیم‌گیری مراجع. این اصل که در فرآیندهایی مانند رضایت آگاهانه و حق انتخاب مراجع برای تصمیم‌گیری در مورد درمانش تجلی می‌یابد، یکی از پایه‌های اخلاق حرفه‌ای است.

سؤال ۴۴

دانستن و رعایت قوانین و مقررات کشور و اصول اخلاق حرفه‌ای، ذیل کدام اصل اخلاقی قرار می‌گیرد؟

پاسخ:

اصل مسئولیت‌پذیری (Responsibility). این اصل ایجاب می‌کند که روان‌شناس نه تنها در قبال مراجع، بلکه در قبال جامعه و قوانین حاکم بر حرفه خود نیز پاسخگو باشد و آگاهی از این قوانین بخشی از مسئولیت حرفه‌ای اوست.

سؤال ۴۵

اگر دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری، خود را با عنوان «دکتری» یا «دکتر» معرفی کند، کدام اصل اخلاقی را زیر پا گذاشته است؟

پاسخ:

اصل صلاحیت (Competence). این اصل بیان می‌کند که روان‌شناسان باید توانایی‌ها و مدارک خود را به درستی و بدون اغراق معرفی کنند و از عناوینی که هنوز به طور کامل و رسمی احراز نکرده‌اند (یعنی فارغ‌التحصیل نشده‌اند)، استفاده ننمایند.

سؤال ۴۶

آیا دانشجوی کارشناسی ارشد که در حال گذراندن دوره کارورزی است، مجاز به چاپ کارت ویزیت و تبلیغ مستقل برای خدمات خود است؟

پاسخ:

خیر. هر نو تبلیغ مجاز نیست. کارورز تحت نظارت یک سوپروایزر فعالیت می کند و نمی تواند به صورت مستقل دفتر تأسیس کرده، برای خود تبلیغ کند یا مراجع جذب نماید. هر نوع فعالیت تبلیغی مستقل برای کارورزان مجاز نیست.

سؤال ۴۷

در کدام مورد می توان اصل رازداری را نادیده گرفت؟

پاسخ:

وجود یک بیماری مسری که خطر جدی برای دیگران دارد.
این مورد نیز یکی از استثنائات اصل رازداری است که در آن، سلامت عمومی بر محرمانگی اطلاعات فردی اولویت پیدا می کند.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۴۸

مصاحبه علامت‌گرا (Symptom-Oriented Interview) بر چه مؤلفه‌هایی استوار است؟

پاسخ:

توصیف دقیق نشانه‌ها، علائم و رفتارهای قابل مشاهده مراجع. این نوع مصاحبه که هدف اصلی آن رسیدن به یک تشخیص دقیق بر اساس راهنماهایی مانند DSM است، بر جمع‌آوری داده‌های عینی (نشانه‌ها) و ذهنی (علائم) متمرکز است و با مصاحبه بینش‌گرا که به دنبال فهم تعارض‌های زیربنایی است، تفاوت دارد.

سؤال ۴۹

کدام رویکرد درمانی، تمرکز اصلی خود را بر دوران کودکی قرار می‌دهد؟

پاسخ:

رویکردهای بینش‌گرا (Insight-Oriented). این دسته از رویکردها، که شامل درمان‌های روان‌پویشی و تحلیلی است، بر این فرض استوارند که تعارضات حل نشده و تجربیات دوران

کودکی، الگوهای رفتاری و هیجانی فرد در بزرگسالی را شکل می‌دهند.

سؤال ۵۰

اگر مراجع در جلسه درمان سکوت کند یا کم‌حرف باشد، بهترین واکنش چیست؟

پاسخ:

استفاده از پرسش‌های بازپاسخ (Open-Ended Questions). این نوع پرسش‌ها (مانند "چه چیزی باعث شده امروز به اینجا بیایید؟") مراجع را تشویق می‌کند تا به جای پاسخ‌های کوتاه «بله/خیر»، به توصیف و تشریح تجربیات خود بپردازد و فضای امنی برای گشایش و کاوش بیشتر فراهم می‌کند.

سؤال ۵۱

حداقل مدرک تحصیلی برای دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام روان‌شناسی چیست؟

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

پاسخ:

مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های روان‌شناسی یا مشاوره.

سؤال ۵۲

برای فردی که صرفاً با مشکل استرس (و نه یک اختلال اضطرابی مشخص) مراجعه کرده، کدام مداخله در اولویت است؟

پاسخ:

آموزش مهارت‌های آرام‌سازی (Relaxation). برای مدیریت استرس عمومی و غیرپیچیده، آموزش تکنیک‌های آرام‌سازی مانند تنفس عمیق یا آرام‌سازی پیشرونده عضلانی، یک مداخله اولیه، مؤثر، متمرکز و مبتنی بر اصل صرفه‌جویی (parsimony) است.

سؤال ۵۳

در کدام رویکرد درمانی به باورهای ناسازگار اولیه توجه می‌شود؟

پاسخ:

طرح‌واره درمانی (Schema Therapy). اگرچه CBT به افکار و باورهای ناکارآمد می‌پردازد، اما طرح‌واره درمانی به طور خاص بر شناسایی و تغییر «طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه» که الگوهای عمیق و ریشه‌داری هستند که در کودکی شکل گرفته‌اند، متمرکز است. **گرچه منظور دقیق طراح سوال مشخص نیست و احتمال گزینه شناختی رفتاری هم هست.**

سؤال ۵۴

چه زمانی یک روان‌شناس می‌تواند اطلاعات مراجع را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد؟

پاسخ:

تنها با دریافت نامه رسمی و حکم از دادگاه. روان‌شناس نباید تحت فشار یا به درخواست مراجع یا هر فرد دیگری اطلاعات را افشا کند. افشای اطلاعات تنها در صورتی مجاز است که یک مرجع قانونی صالح، حکم کتبی ارائه دهد.

سؤال ۵۵

برای ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی در جمعیت عمومی، کدام آزمون مناسب‌تر است؟

پاسخ:

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (MMPI). این آزمون یک ابزار گسترده برای ارزیابی آسیب‌شناسی روانی عمومی و صفات شخصیتی در جمعیت عمومی و بالینی است.

سؤال ۵۶

در مشاوره زوجی برای ارزیابی مشکلات شخصیتی یا ظن به اختلال شخصیت، کدام آزمون ارجح است؟

پاسخ:

آزمون بالینی چندمحوری میلون (Millon Clinical Multiaxial Inventory - MCMI). این آزمون به طور خاص برای ارزیابی اختلالات شخصیت و نشانه‌های بالینی منطبق با محوره‌های DSM طراحی شده و هنجاریابی آن بر روی جمعیت بالینی صورت گرفته است، که آن را به ابزار انتخابی برای این هدف تبدیل می‌کند.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۵۷

ارزیابی وضعیت روانی مراجع (Mental Status Examination) در چه زمانی از فرآیند درمان باید انجام شود؟

پاسخ:

در تمام جلسات. ارزیابی وضعیت روانی یک رویداد یکباره نیست، بلکه فرآیندی مداوم برای رصد تغییرات در وضعیت هیجانی، شناختی و رفتاری مراجع، سنجش پیشرفت درمان و ارزیابی خطرات احتمالی در طول فرآیند درمان است.

سؤال ۵۸

ابزاری که با عنوان «سَد پرسنز» (SADPERSONS) شناخته می‌شود، برای سنجش چه چیزی به کار می‌رود؟

پاسخ:

مقیاس SADPERSONS یکی از ابزارهای غربالگری و سنجش شدت خطر خودکشی است. این مقیاس یک ابزار یادآور (Mnemonic) برای ارزیابی سریع عوامل خطر خودکشی است. لازم به ذکر است که مطالعات جدید

حساسیت و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی آن را پایین ارزیابی کرده و استفاده از آن به تنهایی برای ارزیابی جامع خطر خودکشی توصیه نمی‌شود.

سؤال ۵۹

مراجعی که می‌گویند فرصت‌های زیادی را در زندگی از دست داده است، بیشتر نشانه کدام اختلال است؟

پاسخ:

افسردگی. نشخوار فکری درباره گذشته، احساس گناه و پشیمانی از ویژگی‌های شناختی بارز اختلال افسردگی اساسی است، در حالی که نگرانی درباره آینده بیشتر مشخصه اختلالات اضطرابی است.

سؤال ۶۰

اگر در جلسه روان‌درمانی متوجه افکار خودکشی مراجع شوید، اولین و بهترین اقدام چیست؟

پاسخ:

ارزیابی دقیق خطر خودکشی. قبل از هر اقدامی مانند اطلاع به خانواده، ارجاع فوری یا بستری کردن، اولین وظیفه درمانگر انجام یک ارزیابی جامع و دقیق از شدت، برنامه، قصد و دسترسی به ابزار خودکشی است. اقدامات بعدی بر اساس نتایج این ارزیابی صورت می‌گیرد.

سؤال ۶۱

استادی که صرفاً به دلیل دریافت هزینه، به فردی گواهینامه آموزشی اعطا می‌کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ:

این کار جایز نیست و مصداق بارز تقلب، بدآموزی و تخلف حرفه‌ای است. اعطای گواهینامه باید منوط به احراز صلاحیت و گذراندن کامل دوره آموزشی باشد، نه صرفاً پرداخت هزینه.

سؤال ۶۲

کودکی به نام علی در مدرسه به معلم گوش نمی‌دهد، با دیگران دعوا می‌کند و رفتارهای تکانشی دارد. تشخیص محتمل چیست؟

پاسخ:

نافرمانی مقابله ای (odd) مشخصه اصلی اختلال سازگاری، واکنش نامتناسب و نامطلوب فرد به یک یا چند عامل استرس‌زای قابل شناسایی در زندگی اوست. این واکنش معمولاً در قالب احساسات منفی، افکار آشفته، و تغییرات رفتاری بروز می‌کند و باعث اختلال در عملکرد روزمره فرد می‌شود. به عبارت دیگر، اختلال سازگاری زمانی تشخیص داده می‌شود که فرد به یک رویداد استرس‌زا، مانند از دست دادن شغل، طلاق، یا بیماری، واکنش بیش از حد نشان دهد و این واکنش باعث شود که در عملکرد شغلی، تحصیلی، یا اجتماعی او اختلال ایجاد شود. این واکنش معمولاً در عرض ۳ ماه پس از شروع عامل استرس‌زا ظاهر می‌شود و بیش از ۶ ماه طول نمی‌کشد. به طور خلاصه، مشخصه اصلی اختلال سازگاری، واکنش نامتناسب به یک عامل استرس‌زا و اختلال در عملکرد فرد به دلیل این واکنش است. مشخصه اصلی اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) الگوی رفتاری مداوم و

مکرر نافرمانی، مخالفت و دشمنی نسبت به اقتدار است. این رفتارها اغلب شامل بحث و جدل با بزرگسالان، به ویژه والدین و معلمان، نافرمانی از دستورات، تحریک دیگران و عصبانیت و تحریک پذیری است. همچنین طبق متن DSM درجات شدت: خفیف علائم فقط در یک محیط (مثلاً در خانه) رخ می‌دهند. متوسط علائم در حداقل دو محیط (مثلاً در خانه و مدرسه) رخ می‌دهند. شدید علائم در سه محیط یا بیشتر (مثلاً در خانه، مدرسه و با همسالان) رخ می‌دهند.

سؤال ۶۳

اگر مراجع فاش کند که با یک فرد متأهل در رابطه عاطفی است، واکنش مناسب درمانگر چیست؟

پاسخ:

بررسی و کاوش بی‌طرفانه دلایل مراجع برای ورود و ماندن در چنین رابطه‌ای. نقش درمانگر، قضاوت اخلاقی، گزارش دادن یا ترغیب مراجع به قطع رابطه نیست، بلکه کمک به او برای رسیدن به بینش در مورد نیازها، الگوها و پیامدهای این انتخاب در زندگی‌اش است.

سؤال ۶۴

اگر مراجع یک سؤال شخصی از درمانگر بپرسد (مانند «آیا شما مواد مخدر مصرف می کنید؟»)، پاسخ مناسب چیست؟

پاسخ:

کاوش در مورد انگیزه و معنای سؤال برای مراجع، از طریق پرسشی مانند: «چه چیزی باعث شد این سؤال را از من بپرسید؟». این پاسخ، کانون توجه را از زندگی شخصی درمانگر به دنیای درونی مراجع بازمی گرداند و فرصتی برای بررسی نگرانی ها، ترس ها یا فرافکنی های احتمالی مراجع فراهم می کند.

سؤال ۶۵

کدام گزینه در مورد شرایط عضویت در سازمان نظام روان شناسی صحیح است؟

پاسخ:

عضویت برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های روان شناسی و مشاوره امکان پذیر است.

فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر مانند علوم تربیتی یا علوم اجتماعی واجد شرایط عضویت نیستند.

سؤال ۶۶

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران چه نوع سازمانی است؟

پاسخ:

یک سازمان غیردولتی و مستقل است که بر اساس قانون مصوب مجلس، وظیفه ساماندهی، نظارت و صدور مجوز برای فعالیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران را بر عهده دارد.

سؤال ۶۷

اگر فردی که از قبل تعارضات بین‌فردی داشته، دچار یک اختلال روانی (مانند افسردگی) شود، چه اتفاقی برای تعارضات او می‌افتد؟

پاسخ:

تعارضات بین فردی او تشدید شده یا گسترده تر می شود.
اختلال روانی می تواند توانایی فرد برای مدیریت هیجانات، درک دیدگاه دیگران و حل مؤثر مشکلات را کاهش دهد و در نتیجه، مشکلات رابطه ای موجود را تشدید کند یا تعارضات قدیمی و حل نشده را مجدداً فعال سازد.

سؤال ۶۸

اگر درمانگر در حین درمان متوجه اشتباه خود شود، چه باید بکند؟

پاسخ:

پذیرش صادقانه و شفاف اشتباه و عذرخواهی از مراجع و تلاش
برای اصلاح آن. این عمل نشان دهنده شفافیت، فروتنی و مسئولیت پذیری حرفه ای است و نه تنها به رابطه درمانی آسیب نمی زند، بلکه می تواند با الگوسازی یک رفتار سالم، آن را تقویت کند.

سؤال ۶۹

اگر زبان یا لهجه مراجع برای درمانگر نامفهوم باشد و ارتباط مؤثر را مختل کند، بهترین اقدام چیست؟

پاسخ:

ارجاع دادن مراجع به همکاری که با آن زبان یا لهجه آشناست. ادامه درمان در شرایطی که ارتباط کلامی مؤثر برقرار نیست، غیراخلاقی و غیرمؤثر است و به منافع مراجع آسیب می‌زند. استفاده از مترجم نیز می‌تواند یک گزینه باشد، اما با ملاحظات مربوط به رازداری همراه است.

سؤال ۷۰

اگر مراجع سؤال شخصی از روان‌شناس بپرسد، پاسخ صحیح چیست؟

پاسخ:

با احترام توضیح داده شود که این سؤال به فرآیند مشاوره مربوط نیست. درمانگر نباید به سؤالات شخصی پاسخ دهد، بلکه می‌تواند انگیزه پشت سؤال را مورد کاوش قرار دهد تا به درک بهتری از دنیای درونی مراجع دست یابد.

سؤال ۷۱

اگر پسر و دختری در مشاوره پیش از ازدواج از مشاور اصرار کنند که والدینشان را برای ازدواج راضی کند، واکنش صحیح چیست؟

پاسخ:

عدم دخالت مستقیم و راهنمایی زوج برای اینکه خودشان این مسئله را مدیریت کنند. نقش مشاور، توانمندسازی زوجین برای حل مشکلاتشان است، نه حل کردن مشکلات به جای آنها یا وساطت کردن.

سؤال ۷۲

وظیفه پیشگیری از خطر خودکشی در جامعه بر عهده چه کسی است؟

پاسخ:

یک وظیفه همگانی است. این مسئولیت تنها بر عهده متخصصان سلامت روان نیست، بلکه شامل تمام اعضای جامعه، از جمله پزشکان، مددکاران، خانواده و دوستان می شود که باید در شناسایی افراد در معرض خطر و حمایت از آنها نقش ایفا کنند.

سؤال ۷۳

اگر یک کودک در اتاق درمان اطلاعات ندهد و همکاری نکند،
راهکار اولیه چیست؟

پاسخ:

گرفتن اطلاعات از والدین. اگرچه استفاده از ابزارهای
غیرکلامی مانند بازی و نقاشی برای ایجاد ارتباط با کودک
بسیار مهم است، اما والدین منبع اطلاعاتی کلیدی و ضروری
برای درک مشکل کودک و زمینه آن هستند. بنابراین،
مصاحبه با والدین یک گام بنیادی در ارزیابی کودک است.
چالش در این سوال گرفتن اطلاعات از والدین یا استفاده از ابزارهای
غیرکلامی مانند بازی و نقاشی بود. شاید طراح بر خلاقیت تاکید دارد!

سؤال ۷۴

مهم‌ترین مؤلفه در اخلاق حرفه‌ای چیست؟

پاسخ:

مسئولیت‌پذیری (Responsibility). در میان اصول
اخلاقی، مسئولیت‌پذیری به عنوان یک تعهد بنیادین برای
حفظ منافع مراجع، پاسخگویی در قبال اقدامات حرفه‌ای و
رعایت قوانین، مؤلفه‌ای محوری و درونی در نظر گرفته
می‌شود.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۷۵

کامل‌ترین مدل برای تبیین علت اختلالات روان‌شناختی چیست؟

پاسخ:

مدل زیستی-روانی-اجتماعی-معنوی. این مدل بر تعامل پیچیده عوامل بیولوژیک، روان‌شناختی و اجتماعی-فرهنگی و مباحث معنوی تأکید دارد. گرچه سه رکن اصلی و استاندارد که در تمام محافل علمی پذیرفته شده است، برخی متخصصان بعد معنوی (Spiritual) را نیز به آن اضافه می‌کنند.

سؤال ۷۶

اگر درمانگر، مراجع خود را به صورت اتفاقی در یک مکان عمومی ببیند، بهترین واکنش چیست؟

پاسخ:

یک احوالپرسی کوتاه، محترمانه و خنثی. درمانگر باید از ورود به صحبت‌های طولانی یا درمانی اجتناب کند تا حریم خصوصی مراجع و مرزهای حرفه‌ای رابطه حفظ شود. حق تقدم در شروع ارتباط با مراجع است تا او در موقعیت ناخوشایند قرار نگیرد.

سؤال ۷۷

اگر مراجع نخواست در مورد مسائل خانودگی اش صحبت شود،
ایا درمانگر می تواند دخالت کند؟

پاسخ:

خیر مرز درمان یا مرز حرفه ای باید رعایت شود. رضایت اگانه
در درمان بسیار مهم است.

سؤال ۷۸

چه کسی می تواند پروانه اشتغال دریافت کند؟

پاسخ:

فردی که حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته
روانشناسی یا مشاوره را داشته و عضو سازمان نظام
روانشناسی باشد. دانشجو بودن برای دریافت پروانه کافی
نیست.

سؤال ۷۹

اگر مراجع انجام تکلیفی را مغایر با باورهای مذهبی خود بداند، واکنش درمانگر چه باید باشد؟

پاسخ:

تکالیف باید با عقاید مذهبی مراجع تطبیق داده شوند. درمانگر موظف است به باورها و ارزش‌های مراجع احترام بگذارد و مداخلات درمانی را به شیوه‌ای حساس از نظر فرهنگی و مذهبی (بومی‌سازی) طراحی و اجرا کند.

سؤال ۸۰

اگر مراجع از درمانگر بخواهد در دادگاه علیه همسرش شهادت دهد، که او را در اتاق کتک زده است واکنش صحیح چیست؟

پاسخ:

عدم پذیرش درخواست، مگر اینکه از سوی دادگاه به صورت رسمی و کتبی احضار شود. درمانگر نباید به عنوان شاهد در دعاوی شخصی مراجع خود شرکت کند، زیرا این کار مرزهای درمانی را مخدوش کرده و او را از نقش بی‌طرف خارج می‌کند. تنها استثنا، حکم قانون و احضاریه دادگاه است.

سؤال ۸۱

مرجع صدور پروانه‌های اشتغال در حوزه روان‌شناسی و مشاوره کجاست؟

پاسخ:

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران. این سازمان طبق قانون مصوب مجلس، تنها مرجع قانونی برای این امر است.

سؤال ۸۲

شاخص‌های اصلی سلامت روان کدامند؟

پاسخ:

هیجان، رفتار و فکر. بر پایه‌ی الگوی شناختی-رفتاری (Cognitive-Behavioral Model) این است که سه مؤلفه‌ی هیجان (Emotion)، رفتار (Behavior) و تفکر (Cognition) ارکان اصلی تشکیل‌دهنده‌ی سلامت روان محسوب می‌شوند. این سه مؤلفه به‌صورت متقابل و پویا با یکدیگر تعامل دارند و سلامت روانی در گرو تعادل، هماهنگی و سازگاری میان آن‌هاست. در این چارچوب، مؤلفه‌هایی نظیر

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

انگیزش (Motivation) یا کارآمدی (Efficacy) ممکن است به عنوان پیامدهای عملکرد مطلوب این سه رکن اساسی در نظر گرفته شوند، اما جزء شاخص‌های بنیادین و ساختاری سلامت روان به شمار نمی‌آیند. بنابراین، گزینه‌ی «هیجان، رفتار و فکر» صحیح است، چرا که بیانگر اجزای اصلی و بنیادین مدل نظری رایج در تبیین و مداخله در حوزه‌ی سلامت روان است.

سؤال ۸۳

اگر زوج در جلسه اول به دنبال راهکار فوری برای طلاق باشد، واکنش صحیح چیست؟

پاسخ:

گوش دادن فعال و عدم ارائه راهکار فوری. وظیفه درمانگر در ابتدا، ایجاد فضا برای شنیدن کامل داستان مراجع و درک عمیق مشکل است. ارائه راهکار، به ویژه در مورد تصمیمات مهمی مانند طلاق، در جلسه اول اقدامی شتابزده و غیراخلاقی است.

سؤال ۸۴

آیا دانشجوی دکتری روان‌شناسی که هنوز دفاع نکرده، مجاز به استفاده از عنوان «دکتر» است؟

پاسخ:

خیر، مجاز نیست. تا زمانی که فرد به طور رسمی فارغ‌التحصیل نشده و مدرک خود را دریافت نکرده باشد، استفاده از این عنوان نقض «اصل صلاحیت» (Principle of Competence) محسوب می‌شود.

سؤال ۸۵

اگر مشاور مجرد باشد و مراجع هم مجرد باشد درخواست ازدواج کند؟

پاسخ:

خیر، اکیداً مجاز نیست. این عمل مصداق بارز رابطه دوگانه و سوءاستفاده از قدرت است و در تمام نظام‌نامه‌های اخلاقی ممنوع می‌باشد. این ممنوعیت شامل مراجع فعلی و حتی تا مدت زمان قابل توجهی پس از خاتمه درمان نیز می‌شود.

«این تحلیل صرفاً آموزشی است و هیچ مسئولیت

قانونی برای نگارنده در پی ندارد. استفاده تجاری

یا انتشار بدون ذکر منبع ممنوع است.»

دکتر محمد ترکمان

سؤال ۸۶

برای فعالیت حرفه‌ای در حوزه خدمات مشاوره چه چیزی لازم است؟

پاسخ:

هم عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی و هم داشتن پروانه اشتغال. عضویت به تنهایی برای ارائه خدمات درمانی مستقل کافی و قانونی نیست.

سؤال ۸۷

برای تبدیل شدن به یک درمانگر حرفه‌ای، کدام مورد بیشترین کمک را می‌کند؟

پاسخ:

گذراندن دوره‌های آموزشی و کارورزی تحت نظارت. دانش نظری به تنهایی کافی نیست و کسب مهارت عملی از طریق کارورزی و آموزش‌های تخصصی برای تبدیل شدن به یک درمانگر شایسته، ضروری است.

این سوال به گونه دیگر هم مطرح شده است. جایگاه کارورزی در گرفتن پروانه اشتغال کجاست؟ پیش نیاز درمانگری پاسخ بستری برای انتقال دانش است.

سؤال ۸۸

برای افزایش خلاقیت در کودکان اتاق درمان چه باید کرد؟
پاسخ:

اتاق فضای نقاشی و بازی داشته باشیم. تشویق آن‌ها به تولید ایده‌های جدید. ایجاد فضایی امن و پذیرا که در آن کودک برای ایده‌پردازی و آزمون و خطا تشویق شود، به رشد خلاقیت او کمک می‌کند.

سؤال ۸۹

اگر شرکتی برای استخدام از تست MMPI استفاده کند و سؤالات برای متقاضیان تکراری و آشنا باشد، نتایج چه وضعیتی خواهند داشت؟

پاسخ:

نتایج تضعیف شده و احتمالاً نامعتبر هستند. آشنایی قبلی با سؤالات یک آزمون روان‌شناختی، به ویژه در زمینه‌های استخدامی، می‌تواند منجر به مدیریت پاسخ‌ها و کاهش اعتبار نتایج شود.

سؤال ۹۰

اگر مراجع در مورد موضوعی که درمانگر مطرح کرده بگوید «این نگرانی اصلی من نیست»، واکنش مناسب چیست؟

پاسخ:

احترام به نظر مراجع و عدم اصرار بر آن موضوع. درمان فرآیندی مشارکتی است و درمانگر باید به اولویت‌ها و دیدگاه مراجع احترام بگذارد. ضمن توضیح دلیل اهمیت موضوع از دیدگاه خود، در نهایت حق انتخاب با مراجع است.

سؤال ۹۱

کارکرد بررسی عاطفه (Affect) در ارزیابی وضعیت روانی چیست؟

پاسخ:

درک وضعیت هیجانی لحظه‌ای مراجع. عاطفه، تظاهر بیرونی و کوتاه‌مدت حالت هیجانی فرد است (مانند خوشحال، غمگین، بی تفاوت) و بررسی آن به درمانگر کمک می‌کند تا وضعیت هیجانی مراجع را در لحظه ارزیابی کند. این مفهوم با «خُلق» (Mood) که یک حالت هیجانی پایدارتر و طولانی‌مدت است، تفاوت دارد.

سؤال ۹۲

انتخاب رنگ روشن برای دیوار اتاق مشاوره چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

پاسخ:

کمک به ارتباط بهتر و ایجاد حس گشودگی و آرامش در مراجع. محیط فیزیکی اتاق درمان می‌تواند بر فرآیند درمانی تأثیر بگذارد و رنگ‌های روشن و آرامش‌بخش می‌توانند به ایجاد فضایی امن و پذیرا کمک کنند.

سؤال ۹۳

اگر مراجع از موضوع اصلی بحث منحرف شود، چه باید کرد؟

پاسخ:

بازگرداندن محترمانه مراجع به موضوع اصلی با استفاده از سؤالات هدایتگرانه. یکی از وظایف درمانگر، نظم دادن به فرآیند جلسه و ذهن مراجع است. این کار باید با ظرافت و همدلی انجام شود تا مراجع احساس نکند که به حرف‌هایش بی‌توجهی شده است.

سؤال ۹۴

درمانگر و مراجع چه نوع رابطه‌ای می‌توانند با هم داشته باشند؟

پاسخ:

صرفاً رابطه حرفه‌ای مشاور و مراجع. هرگونه رابطه دیگری (دوستی، خانوادگی، کاری، مالی و غیره) به عنوان رابطه دوگانه تلقی شده و ممنوع است.

سؤال ۹۵

اگر مراجع زیر سن قانونی باشد، پیش‌نیاز شروع درمان چیست؟

پاسخ:

کسب رضایت آگاهانه از ولی یا قیم قانونی او. بر اساس قوانین و اصول اخلاقی، برای ارائه خدمات درمانی به افراد زیر سن قانونی، رضایت والدین یا سرپرست قانونی الزامی است.

سؤال ۹۶

وقتی متوجه می شوید که افرادی برای مشاوره ازدواج مراجعه کردند ولی مشکل دارند چه اقدامی انجام می دهید.

پاسخ:

به آنها کمک می کنیم و راهنمایی می دهیم تا خود تصمیم بگیرند. ما نباید به جای مراجع تصمیم بگیریم یا مستقیم اعلام کنیم که مناسب هم نیستند. تصمیم را باید به خود فرد واگذار کنیم.

سوال ۹۷

برای اینکه سلامت روان جامعه رو ارتقا بدهیم سازمان نظام چه اقدامی باید انجام دهد؟

پاسخ:

در متن قانون سازمان آمد است هدف سازمان تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره. حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران. حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران است و این موارد شامل اقدامات مختلف برای ارتقا سلامت روان جامعه می شود.

سوال ۹۸

اگر مراجعی در جلسه اول بگوید که با دوست خود دچار مشکل شده است چه اقدامی انجام می دهید؟

پاسخ:

از مراجع می خواهیم تا در مورد مشکل بیشتر توضیح بدهد. دریافت شرح مشکل و تشویق مراجع به صحبت کردن اولین قدم است. سپس با توجه به فرایند گفتگو به مراجع برای حل مشکل کمک می کنیم.

سوال ۹۹

وقتی بین مراجع و درمانگر اختلافات قومیتی وجود داشته باشد...

پاسخ:

روی رابطه درمانگر و مراجع تاثیر دارد. بهترین حالت زمانی است که درمانگر برای مراجع خنثی باشد. هر گونه مساله ای که روی رابطه درمانگر و مراجعه تاثیر بگذارد مانند رابطه دوستی یا سابقه همکاری یا اختلافات قومیتی، می تواند مسیر درمان را منحرف کند.

سوال ۱۰۰

نشانه موثر بودن جلسات درمانی چیست؟

پاسخ:

مراجع احساس درک شدن میکند و به سمت تغییر حرکت می کند. در مورد این سوال، چون گزینه ها موجود نبوده، نمی توان با قطعیت بیشتر نظر داد.

این فایل در نسخه های بعدی کامل تر و ویرایش خواهد شد.